

Perfuração de víscera oca · abdome agudo

Perfuração = ar livre + peritonite. Ressuscite, antibiótico de amplo espectro e controle de foco cirúrgico precoce — atraso eleva mortalidade.

Causas clássicas

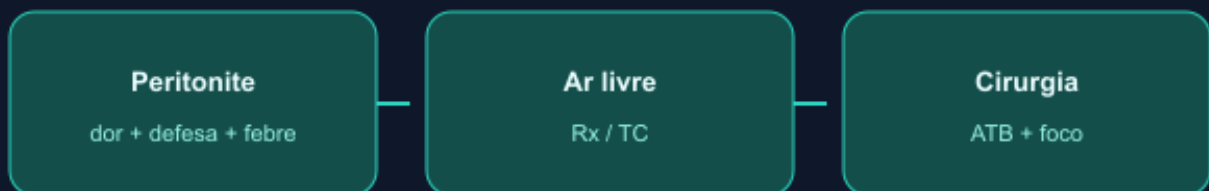
Lembre - Causas clássicas

Úlcera péptica perforada, diverticulite perforada, apendicite furada, trauma e corpo estranho. Em úlcera, epigastria súbita 'em punhalada' é o clichê.

Fluxo: clínica de peritonite !' Rx/TC com ar livre !' cirurgia de urgência após estabilização.

Perfuracao oca

Suspeita -> imagem -> controle de foco



Conduta perioperatória

- ABC, volume, correção eletrolítica e sonda se íleo
- ATB cobrindo Gram⁺ e anaeróbios (e Gram⁺ conforme protocolo local)
- TC se estável e dúvida; Rx tórax/abdômen pode mostrar pneumoperitônio
- Cirurgia: lavagem, fechamento/resseção e drenagem conforme sítio e contaminação

Sinais de alerta

Achado | Significado

Defesa/rigidez difusa | Peritonite generalizada

Ar sob diafragma | Perfuração oca até prova em contrário

Lactato⁺ / hipotensão | Sepsis abdominal — urgência

Imunossuprimido | Clínica pode ser atenuada

Armadilha de prova

Atencao - Armadilha de prova

Não trate perfuração com 'observação prolongada' se há peritonite difusa. Antibiótico isolado não substitui controle de foco. Em úlcera, lembrar *Helicobacter* no follow-up — mas a urgência é cirúrgica.

Para a prova — escalas e macetes

Lembre - Para a prova — escalas e macetes

Perfuração de víscera oca: pneumoperitônio no Rx/TC + peritonite = cirurgia de urgência após reanimação breve.

Ar livre + clínica de abdome agudo perfurativo fecha indicação na maioria dos casos.

Sinais de perfuracao (Rx/TC)

Pneumoperitonio e equivalentes

- 1 Rx: ar sob diafragma (ortostase)
- 2 Rx: Rigler / ar em flanco (decubito)
- 3 TC: ar livre peritoneal
- 4 TC: extravasamento de contraste
- 5 TC: liquido livre / inflamacao focal
- 6 Clínica: peritonite difusa

TC e mais sensível que Rx

Causas clássicas

Lembre - Causas clássicas

Úlcera péptica perfurada, diverticulite perfurada, apendicite perfurada, trauma, corpo estranho, anastomose. Localização da dor inicial dá pista (epigástrico vs FID vs flanco).

Conduta

- Jejum, volume, ATB amplo (aeróbios + anaeróbios), analgesia
- Sonda se distensão/vômitos; corrigir eletrólitos
- Cirurgia (geralmente laparoscopia/laparotomia) para controle da fonte
- Selecionados estáveis com perfurado selado podem ter via não operatória sob vigilância estreita

Rx vs TC

Exame | Papel

Rx tórax/abd ortostático | Ar subdiafragmático — rápido e barato

Rx em decúbito lateral | Se não puder ficar em pé

TC com contraste | Confirma, localiza e vê complicações

Armadilha

Atencao - Armadilha

Rx normal não exclui perfuração — se alta suspeita clínica, vá para TC ou sala conforme gravidade.

Material de estudo para residência (R1). Não substitui protocolo institucional nem conduta clínica.

www.medhubr1.com.br - MedHub R1